

Freilegung und Anschlingung

Ein retinierter oder verlagelter Zahn wird für die kieferorthopädische Einordnung zugänglich gemacht.

Häufig betrifft dies einen Eckzahn oder Zahn 37, den zweiten großen Backenzahn links unten.

Ziel und Ablauf

Nach Untersuchung, Röntgenplanung und Abstimmung mit der Kieferorthopädie wird der Zahn örtlich betäubt. Wir eröffnen das Zahnfleisch und tragen bei Bedarf etwas Knochen über der Krone ab. Ein kleines Befestigungselement mit Zugkette wird auf den Zahn geklebt. Die Wunde wird je nach Verfahren geschlossen oder bleibt gezielt offen.

Die spätere Bewegung oder Aufrichtung erfolgt durch die Kieferorthopädie über viele Monate. Ein DVT ist nur bei einer konkret begründeten zusätzlichen 3D-Fragestellung nötig. Der Behandlungserfolg ist nicht garantiert.

Alternativen und Risiken

Je nach Befund: kontrolliertes Beobachten, Platzschaffen, Beseitigen eines Hindernisses, Freilegung ohne Kette oder Entfernung mit Lückenplanung; ausgewählt operative Aufrichtung oder Transplantation. Ohne Behandlung sind unter anderem Nachbarwurzelschäden, Entzündung oder Zysten möglich.

Risiken sind Nachblutung, Infektion, Schwellung, Zahn-/Wurzelschäden, Zahnfleischrückgang sowie Ablösen oder Reißen der Kette mit möglichem Zweiteingriff. Selten werden Teile verschluckt oder eingeatmet. Je nach Lage sind Nerv oder Kieferhöhle betroffen. Ein mit Knochen verwachsener Zahn kann unbeweglich bleiben.

Vorher und nachher

- Medikamente, Allergien, Vorerkrankungen und mögliche Schwangerschaft angeben. Verordnete Blutverdünner nicht selbst absetzen.
- Bei Lokalanästhesie normalerweise leicht essen; bei Sedierung/Narkose den persönlichen Nüchternplan beachten. Abholung aus der Praxis verpflichtend.
- Danach schonen, mit Pausen kühlen, nicht kräftig spülen. Erst nach Ende der Betäubung weich und lauwarm essen. Nicht rauchen.
- Kette nicht ziehen, schneiden oder nachspannen. Bei Lockerung zeitnah Praxis und Kieferorthopädie kontaktieren.
- Schmerzmittel nur nach persönlichem Plan; bei Kindern nach Alter und Gewicht. Kein zusätzliches Aspirin/ASS als Schmerzmittel.
- Fäden werden nach 1–2 Wochen entfernt. Die Kette bleibt für die KFO-Behandlung. Kontroll- und KFO-Termine wahrnehmen.

Bei Warnzeichen sofort Kontakt aufnehmen

Anhaltende Blutung trotz 30 Minuten Druck mit einem sauberen Tupfer, Fieber, Eiter oder deutlich zunehmende Schmerzen und Schwellung: Praxis **06151 786540**.

Nach dem Eingriff außerhalb der Praxisprechzeiten: **+49 151 10437450**. Falls nicht erreichbar: zahnärztlicher Notdienst **01805 60 70 11**.

Bei lebensbedrohlicher Notlage, Atemnot, starker Schluckbehinderung oder rascher Schwellung von Mundboden, Hals oder Zunge **sofort 112**.

Die Kurzfassung ergänzt die ausführliche Information und das persönliche Gespräch.